ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/354887663

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ Theoretical Framework and Key Elements of International Rehabilitation Policy: Contents Analysis of WHO Rehabilitation Policy Documents

Article · September 2021

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2021.09.002

CITATIONS
0

READS
136

3 authors, including:



Xiuqi Tang
Wuhan University of Technology
1 PUBLICATION **0** CITATIONS
SEE PROFILE



Zhuoying Qiu
WHO Family International Classification Collaborating Center in China, ICF
14 PUBLICATIONS **211** CITATIONS
SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Zhuoying Qiu on 28 September 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

中国科学引文数据库来源期刊(核心版)(CSCD-C)
中国科技核心期刊-中国科技期刊引证报告源期刊(核心版)(CSTPCD-CJCR)
《中文核心期刊要目总览》入编期刊
“世界卫生组织西太平洋地区医学索引(WPRIM)”期刊
中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊(CAJCED) 中国学术期刊文摘数据库核心版(CSAD-C)收录期刊

ISSN 1006-9771
CN 11-3759/R

中国康复理论与实践

中国康复理论与实践

ZHONGGUO KANGFU LILUN YU SHIJIAN

CHINESE JOURNAL OF REHABILITATION THEORY AND PRACTICE

Volume 27 Number 9 September 2021
2021 年 9 月 第 27 卷 第 9 期

二〇二一年九月 第二十七卷 第九期

专题 辅助技术政策与发展研究

9

ISSN 1006-9771
9 771006 977214 09>

2017 中国精品科技期刊 OUTSTANDING S&T JOURNALS OF CHINA
微信公众号
扫一扫看全文

中国残疾人康复协会
中国医师协会主办
中国康复研究中心

中国康复理论与实践

CHINESE JOURNAL OF REHABILITATION THEORY AND PRACTICE
月 刊 1995年创刊 第27卷 第9期 2021年9月25日 （总第262期）

主 管
中国残疾人联合会
主 办
中国残疾人康复协会
中国医师协会
中国康复研究中心
编 辑
中国康复理论与实践杂志编辑委员会
100068，北京市丰台区角门北路10号
电话：(010)87020374
电子邮箱：cjrtponline@263.net
网址：www.cjrtponline.com
主 编 吴弦光 李建军
本期执行编委 邱卓英
编辑部主任 张爱民
出 版
中国康复理论与实践杂志编辑部
印 刷
北京一二零一印刷有限公司
发 行
国内：北京市报刊发行局
国外：中国国际图书贸易集团有限公司
订 购
全国各地邮局
邮发代号：82-35
国外发行代号：M-6607
邮 购
中国康复理论与实践杂志编辑部
100068，北京市丰台区角门北路10号
电话：(010)87020374
广告发布登记 京丰工商广登字20170027号
定 价
每期30.00元，全年360.00元
中国标准连续出版物号
ISSN 1006-9771
CN 11-3759/R
本期责任编辑 蔡飞鸣 张爱民
[期刊基本参数]CN 11-3759/R*1995*m*A4*124*zh*P*¥30.00**18*2021-09

全部版权归中国康复研究中心所有
未经授权，不得转载、摘编、翻译本刊文章，不得使用本刊的版式设计
除非特别声明，本刊刊出的所有文章不代表主办单位和本刊编委会的观点
如有印刷质量问题，本刊编辑部负责调换

目 次

关于加快推进康复医疗工作发展的意见 …… 993

专稿

国际康复政策架构与核心内容研究：基于世界卫生组织康复政策文件的内容分析
……汤修齐，邱服冰，邱卓英，等 996

专题 辅助技术政策与发展研究

国际辅助技术服务的政策架构、核心内容和发展研究
……杨思创，汤修齐，邱服冰，等 1006
关于辅助技术的几个理论问题 ……朱图陵 1017
中国康复辅助技术咨询师职业技能标准的构建
……谢甘霖，董理权，刘志红，等 1024
我国辅助器具租赁服务相关政策研究 ……熊宝林，赖卿，管思聪 1032

综述

基于ICF成年人休闲体育活动改善心理健康、生活质量和福祉的系统综述
……崔德刚，邱芬，邱服冰，等 1038
虚拟现实技术对帕金森病患者综合平衡能力改善的Meta分析
……刘阳，张孝权，王恒，等 1048
儿童轮椅的临床应用研究进展 ……沈洁，周璇，杜青 1059

临床研究

功能性近红外光谱技术在利手、非利手主动抓握-释放任务下脑区激活研究中的应用……李晁金子，黄富表，杜晓霞，等 1066
血管性认知障碍早期预测机器学习模型的构建……张倩，卞敏洁，何琴，等 1072
经颅直流电刺激调节迷走神经兴奋性对脑卒中后吞咽障碍的效果
……陈佳君，吴登宠，邵湘芝，等 1078
经颅直流电刺激对脑卒中患者上肢运动功能康复的效果
……王伟，宋为群，张艳明，等 1082
五禽戏对帕金森病患者平衡功能、步行能力及生活质量的效果
……曹海豪，孙文玉，席晓明，等 1087
盆底肌训练对神经源性逼尿肌过度活动的效果……栗亮，廖利民，吴娟，等 1093

剪切波弹性成像在辅助软组织松解术后跟腱功能评估中的应用 ……单洁玲，朱俞岚，阮婷婷，等 1098
临床观察
指屈肌主动不足条件下屈指运动时神经肌肉的调控 ……张静，郭峰 1104
辅助技术
足底振动刺激诱发人体特定方向姿势调整的测试系统研究 ……李高峰，梅剑峰，张蒙，等 1110

中国科学引文数据库来源期刊(核心版)(CSCD-C)
中国科技核心期刊-中国科技期刊引证报告源期刊(核心版)(CSTPCD-CJCR)
《中文核心期刊要目总览》入编期刊
“世界卫生组织西太平洋地区医学索引(WPRIM)"期刊
中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊(CAJCED)
中国学术期刊文摘数据库核心版(CSAD-C)收录期刊
《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》执行优秀期刊
万方数据资源系统(China Info)全文收录期刊
日本科学技术振兴机构数据库(JST)收录期刊
《中国学术期刊评价研究报告》(RCCSE-A)
《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊
《中国学术期刊(网络版)》(CAJ-N)首批网络首发期刊
中国医师协会优秀期刊
处方药广告专业媒体

CHINESE JOURNAL OF REHABILITATION THEORY AND PRACTICE

Monthly Established in 1995 Volume 27 Number 9 September 25, 2021 Total Issues 262

Responsible Institution
China Disabled Persons' Federation
Sponsors
China Association of Rehabilitation of Disabled Persons
Chinese Medical Doctor Association
China Rehabilitation Research Center
Editing
Editorial Board of Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice
Jiaomen North Rd 10, Fengtai District, Beijing 100068, China
Tel: 0086-10-87020374
http://www.cjrtponline.com E-mail: cjrtponline@263.net
Editors-in-Chief
WU Xian-guang LI Jian-jun
Executive Editor QIU Zhuo-ying
Managing Director ZHANG Ai-min
Publishing
Editorial Department of Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice
Jiaomen North Rd 10, Fengtai District, Beijing 100068, China
Tel: 0086-10-87020374
Printing
Beijing 1201 Printing Co., Ltd.
Overseas Distribution
China International Book Trading Corporation
Mail-Order and Advertisement
Editorial Department of Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice
Jiaomen North Rd 10, Fengtai District, Beijing 100068, China
Tel: 0086-10-87020374
E-mail: cjrtponline@263.net
CSSN
ISSN 1006 -9771
CN 11 - 3759/R
Editors
CAI Fei-ming ZHANG Ai-min
Copyright © All rights reserved by
China Rehabilitation Research Center
No content published by *Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice* may be reproduced, abrigded or translated without authorization. Please do not use or copy the layout and design of this journal without permission.
All articles published represent the opinions of the authors, and do not reflect the official policy of all sponsors or the Editorial Board, unless this is clearly specified.

CONTENTS

Theoretical Framework and Key Elements of International Rehabilitation Policy: Contents Analysis of WHO Rehabilitation Policy Documents ····· 996
TANG Xiu-qi, QIU Fu-bing, QIU Zhuo-ying, et al.
Framework and Core Content of International Policy on Service of Assistive Technology ····· 1006
YANG Si-chuang, TANG Xiu-qi, QIU Fu-bing, et al.
Conceptual Discussion of Assistive Technology ····· 1017
ZHU Tu-ling
Construction of China Occupational Skills Standard of Assistive Technology Consultants ····· 1024
XIE Gan-lin, DONG Li-quan, LIU Zhi-hong, et al.
Rental Service of Assistive Devices in China: Policy Research ····· 1032
XIONG Bao-lin, LAI Qing, GUAN Si-cong
Mental Health, Quality of Life and Well-being of Recreational Physical Activity for Adults Using ICF: A Systematic Review ····· 1038
CUI De-gang, QIU Fen, QIU Fu-bing, et al.
Effects of Virtual Reality on Balance for Patients with Parkinson's Disease: A Meta-analysis ····· 1048
LIU Yang, ZHANG Xiao-quan, WANG Heng, et al.
Clinical Advance in Pediatric Wheelchair (review) ····· 1059
SHEN Jie, ZHOU Xuan, DU Qing
Application of Functional Near-infrared Spectroscopy in Brain Area Activation Research: Dominant and Non-dominant Hand under Active Grasp-release Task ····· 1066
LI Chao-jin-zi, HUANG Fu-biao, DU Xiao-xia, et al.
Machine Learning Models for Early Prediction of Vascular Cognitive Impairment ····· 1072
ZHANG Qian, BIAN Min-jie, HE Qin, et al.
Effects of Transcranial Direct Current Stimulation over Vagus Nerve on Dysphagia after Stroke ····· 1078
CHEN Jia-jun, WU Deng-chong, SHAO Xiang-zhi, et al.
Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Upper Limb Motor Function for Patients with Stroke ····· 1082
WANG Wei, SONG Wei-qun, ZHANG Yan-ming, et al.

Effects of Wuqinxi on Balance, Walking and Quality of Life for Patients with Parkinson's Disease ·····1087
CAO Hai-hao, SUN Wen-yu, XI Xiao-ming, et al.
Effect of Pelvic Floor Muscle Training on Neurogenic Detrusor Overactivity ·····1093
LI Liang, LIAO Li-min, WU Juan, et al.
Effect of Instrument-assisted Soft Tissue Mobilization on Achilles Tendon Using Shear Wave Elastography ·····1098
SHAN Jie-ling, ZHU Yu-lan, RUAN Ting-ting, et al.
Neuromodulation for Flexion of Fingers under Initiative Inadequate of Flexor Digitorum ·····1104
ZHANG Jing, GUO Feng
Testing System for Analyzing Directionally-specific Postural Adjustments Indued by Plantar Vibratory Stimulation ·····1110
LI Gao-feng, MEI Jian-feng, ZHANG Meng, et al.

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2021.09.002

·专稿·

国际康复政策架构与核心内容研究:基于世界卫生组织康复政策文件的内容分析

汤修齐[1,2,3,4]，邱服冰[1,2,3]，邱卓英[2,3,5]，吕军[6]，周晓英[7]，邱芬[4]，刘静[4]，李安巧[2,3]，陈迪[2,5]，张爱民[5]

1. 深圳大学体育部体育与健康科学研究中心，广东深圳市 518060；2. 世界卫生组织国际分类家族合作中心，北京市 100068；3. 中国ICF研究院，山东潍坊市 261000；4. 武汉理工大学体育部体育科学研究所，湖北武汉市 430070；5. 中国康复研究中心/中国康复科学所，北京市 100068；6. 复旦大学公共卫生学院，上海市 200032；7. 中国人民大学信息资源管理学院，北京市 100872

通讯作者：邱服冰，E-mail：13902932056@163.com；邱卓英，E-mail：qiutiger@hotmail.com

基金项目：1. 国家社会科学基金项目(No. 17ZDA078; No. 20AZD132); 2. 中央财政支持地方高校专项体育部学科建设项目(No. 0000290701)

摘要

目的 运用世界卫生组织(WHO)健康服务构成要素的理论，从健康服务体系视域，对WHO有关康复服务的政策架构与行动战略进行系统的内容分析，探讨WHO国际康复政策的理论基础与方法、康复政策架构以及行动战略的核心内容。

方法 WHO发布的康复相关政策文件包括《健康服务体系中的康复》《健康服务体系中的康复：行动指南》《康复指标清单：康复监测和评估架构配套的工具》和《康复现状系统评估配套工具(STARS)：康复信息收集模板(TRIC)》，形成国际康复政策体系。本研究运用内容分析方法，根据WHO健康服务构成的六大要素，即领导力和治理能力、筹资、健康人力资源、服务提供、医药技术、健康信息系统，详细分析国际康复政策的理论基础与方法、政策架构以及行动战略的核心内容与康复服务优先发展领域。

结果 现代康复服务政策核心依据WHO有关构建以人为本的健康服务、关注健康的社会决定因素的理论，依据《国际功能、残疾与健康分类》的功能、残疾和健康理论，明确发展康复是实现联合国可持续发展目标三，确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉，即“全民健康覆盖”的重要路径。系统分析了领导力和治理能力、筹资、健康人力资源、服务提供、医药技术、健康信息系统六大领域，WHO的国际政策架构、行动战略以及发展内容与优先领域。WHO倡导制定国家康复规划，建立与完善康复治理结构并发展康复治理能力，采取多种途径为发展康复服务筹资。将康复融入现代健康服务体系，在健康服务连续体中提供不同层次的康复服务，在健康服务体系中构建康复服务体系，培训专业人员，建立服务信息网络，提升服务质量和服务覆盖率，关注重点领域和优先项目，以满足不同人群的多样化需求，实现全民健康覆盖。将辅助技术作为医药技术领域纳入康复服务体系。在健康信息系统中，收集有关功能和康复需求的信息以及康复服务结果和影响的数据，并开展基于循证的康复政策系统研究。

结论 基于健康服务体系六大构成要素，从宏观、中观和微观三个层面，系统研究了国际康复政策架构。现代康复发展的理念是要实现全民健康覆盖。发展康复必须建立以人为中心的现代健康服务体系，并且关注社会决定因素。发展康复是实现联合国2030年可持续发展目标的重要举措。国际康复的政策体系围绕康复领导力和治理、康复筹资、康复人力资源、康复服务提供、康复相关医药技术以及康复与健康信息六大领域，从理论与政策、政策行动、实施工具和路径(评价指标体系和实施效果评估)三个层级，构建了康复发展的政策和行动战略以及具体的实施方法与工具的体系。实施WHO康复政策，需要采取如下行动：

作者简介：汤修齐(1999-)，女，汉族，湖南岳阳市人，硕士研究生，主要研究方向：健康与康复政策、身体活动与健康，ICF。通讯作者：邱服冰(1966-)，男，汉族，湖北公安县人，副教授，主要研究方向：体育与健康、康复心理学、运动与康复；邱卓英(1962-)，男，汉族，湖北武汉市人，博士，研究员、教授，世卫组织国际分类家族合作中心联合主任，世卫组织《健康服务体系中的康复》指南制定专家委员会委员，主要研究方向：WHO-FICs、ICF、健康与康复政策、残疾研究、健康与康复科学、康复信息。

加强康复服务领导力、治理、规划和协调能力；构建合理的康复筹资机制，为康复筹措必要资金；健全康复人力资源培养与保障机制；提升康复人员专业能力，提升康复服务提供能力并改善服务质量；提高辅助产品和辅助技术服务的质量与可及性；建立涵盖功能、残疾和康复的健康信息系统并开展康复科学研究。

关键词　健康服务体系；康复；康复政策

Theoretical Framework and Key Elements of International Rehabilitation Policy: Contents Analysis of WHO Rehabilitation Policy Documents

TANG Xiu-qi[1,2,3,4], QIU Fu-bing[1,2,3], QIU Zhuo-ying[2,3,5], LÜ Jun[6], ZHOU Xiao-ying[7], QIU Fen[4], LIU Jing[4], LI An-qiao[2,3], CHEN Di[2,5], ZHANG Ai-min[5]

1. Center of Physical Education, Sport and Health Sciences, Department of Physical Education, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518060, China; 2. WHO-FIC Collaborating Center in China, Beijing 100068, China; 3. China Academy of ICF, Weifang, Shandong 261000, China; 4. Institute for Sport Science, Department of Physical Education of Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070, China; 5. China Rehabilitation Research Centre/China Rehabilitation Science Institute, Beijing 100068, China; 6. School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200032, China; 7. School of Information Resources Management, Renmin University of China, Beijing 100872, China

Correspondence to　*QIU Fu-bing,* E-mail: 13902932056@163.com; *QIU Zhuo-ying,* E-mail: qiutiger@hotmail.com

Supported by　National Social Science Foundation of China (No. 17ZDA078; No. 20AZD132) and Central Finance Support Discipline Construction Project of Special Physical Education Department in Local Universities (No. 0000290701)

Abstract

Objectives To systematically analyze the framework and contents of World Health Organization (WHO) policy and action strategies on rehabilitation using the theory of WHO health service components, to explore the theoretical bases, methodology, framework and core elements of WHO's international rehabilitation policy.

Methods WHO has launched rehabilitation-related policy documents, mainly including *Rehabilitation in Health Systems*, *Rehabilitation in Health Systems: Guide for Action, Rehabilitation Indicator Menu: a tool accompanying the Framework for Rehabilitation Monitoring and Evaluation (FRAME), Template for Rehabilitation Information Collection (TRIC): a tool accompanying the Systematic Assessment of Rehabilitation Situation (STARS),* and established systems of international rehabilitation policy architecture system. Using content analysis, this study analyzed in detail the theoretical basis and methodology of international rehabilitation policy, the policy framework, and the core elements of the action strategy and priority areas of rehabilitation service development in perspective of WHO six building blocks of health system, namely leadership and governance, financing, human resources for health, service delivery, medical technology, and health information systems.

Results WHO rehabilitation policy is developed based on WHO's theories of person-centered health services, social determinants of health, and functioning, disability and health of International Classification of Functioning, Disability and Health. WHO rehabilitation policy recognized that the development of rehabilitation was an important pathway achieving United Nations 2030 Sustainable Development Goals 3, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, i.e. Unlversal Health Coverage. This paper systematically analyzed WHO's international policy framework, action strategies, and development areas, content and priorities in six major areas: leadership and governance, financing, human resources for health, service delivery, medicine and technology, and health information systems. WHO rehabilitation policies advocates to develop national rehabilitation plans, to establish and improve rehabilitation leaderships and the development of mechanism and capacity of rehabilitation governance, to develop multiple approaches of rehabilitation financing, to integrate rehabilitation into health service system, provides different levels of rehabilitation services in the health service continuum, and to build networks of service delivery, to train professionals, to foster rehabilitation information system within health system, to enhance service quality and service coverage, to focus on key areas and priority programs to meet the diverse

needs of different populations, and achieve universal health coverage; to include assistive technology into the rehabilitation service system as a field of medicine and technology; and to collect information on functioning and rehabilitation needs, outcomes and impacts of rehabilitation services in the health information system, and conduct evidence-based researches on rehabilitation systems.

Conclusion The framework and contents of WHO's international rehabilitation policies have systematically reviewed at the macro, meso, and micro levels with the perspective of WHO six building blocks of the health system. The goal of rehabilitation development is to achieve universal rehabilitation coverage. The conceptual theories of rehabilitation are based on the theories of people-centered health services and social determinants of health. Rehabilitation is an important initiative to achieve the United Nations 2030 Sustainable Development Goals. The international rehabilitation health policy system is built on six major areas of rehabilitation: leadership and governance, rehabilitation financing, rehabilitation human resources, rehabilitation service delivery, rehabilitation-related medicine and technology, and rehabilitation and health information system. The policy and action strategies for rehabilitation development, as well as specific implementation paths and methods, at macro, meso and micro levels: theory and policy, policy action, and implementation methods and tools have been reviewed and discussed. The implementation of the WHO rehabilitation policies advocates to take the following actions: strengthening the leadership, governance, planning and coordination capacity of rehabilitation services; constructing a reasonable rehabilitation financing mechanism and raising necessary funds for rehabilitation; improving the training and guarantee mechanism of rehabilitation human resources; enhancing the professional capacity of rehabilitation personnel, improving the capacity of rehabilitation service delivery and improving service quality; improving the quality and accessibility of assistive products and assistive technology services; establishing health information system covering functioning, disability and rehabilitation, and conducting scientific researches on rehabilitation.

Key words: health service system; rehabilitation; policy of rehabilitation

[中图分类号] R49 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-9771(2021)09-0996-10

[本文著录格式] 汤修齐,邱服冰,邱卓英,等. 国际康复政策架构与核心内容研究：基于世界卫生组织康复政策文件的内容分析[J]. 中国康复理论与实践, 2021, 27(9): 996-1005.

CITED AS: TANG Xiu-qi, QIU Fu-bing, QIU Zhuo-ying, et al. Theoretical Framework and Key Elements of International Rehabilitation Policy: Contents Analysis of WHO Rehabilitation Policy Documents [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2021, 27(9): 996-1005.

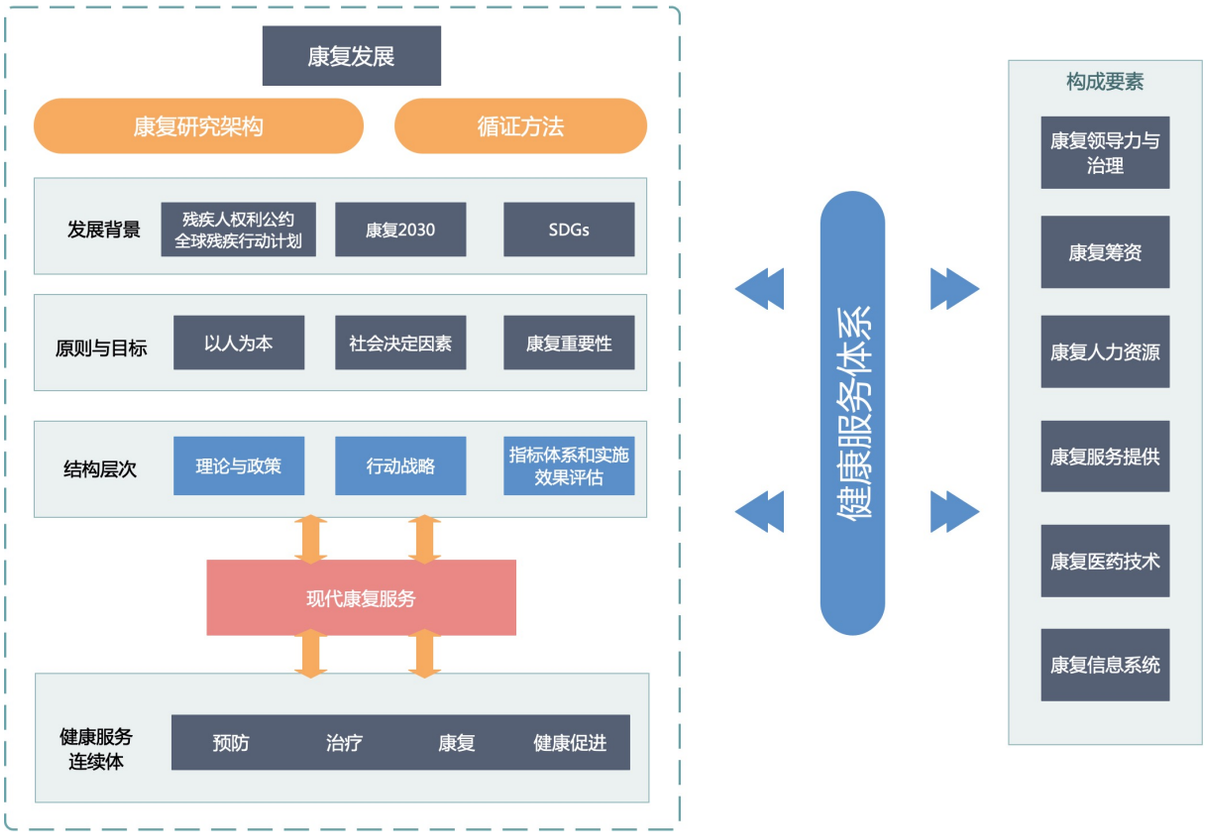
康复是“针对身体功能和结构、活动和参与、环境因素和个人因素采取的一系列措施”[1]。康复是健康服务的重要组成部分，是各国实现联合国“2030可持续发展议程”目标三：“确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉”，即实现“全民健康覆盖”的关键[2]，其内涵是所有个体和社区都能获得所需的卫生服务，包括健康促进、预防、治疗、康复和姑息治疗，同时不会陷入经济困境[3]。全球第一部规范化康复政策指南《健康服务体系中的康复》，为发展康复提出了基于循证研究且知晓的政策建议。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)还发布了《健康服务体系中的康复：行动指南》，作为《健康服务体系中的康复》的配套工具，为基于WHO的健康服务体系架构的康复政策的制定与实施提供了理论、方法、工具与指标体系，共同构成当代国际康复政策体系。本研究基于WHO健康服务体系的理论，应用以人为本的健康保健理论、社会决定因素和《国际功能、残疾与健康分类》(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)关于功能和残疾的方法，基于以循证为依据的政策，对WHO的国际康复政策及行动战略进行系统研究。

1 健康服务体系视域下康复政策研究的方法架构与理论

1.1 健康服务体系视域下康复政策研究架构

基于健康服务六大构成要素和健康服务体系的相关理论，健康服务体系视域下康复发展的研究架构如图1。

康复政策的背景是推动落实联合国《残疾人权利公约》，基于WHO《世界残疾报告》《全球残疾行动计划》和“康复2030”议程等政策文件，促进实现联



注：SDGs：Sustainable Development Goals，联合国可持续发展目标

图 1　健康服务体系高域下康复发展的研究架构

合国可持续发展目标。

康复是健康服务体系的重要部分，发展康复是实现全民健康覆盖的重要举措，需要在健康服务体系的视域下，在预防、治疗、康复和健康促进的健康服务连续体中发展康复服务。

康复政策的主要理论包括以人为本的健康服务理论、健康服务的社会决定因素理论，以及 ICF 有关功能、残疾和健康分类的理论。

WHO 颁布的《健康服务体系中的康复》《健康服务体系中的康复：行动指南》《康复指标清单：康复监测和评估架构配套的工具》和《康复现状系统评估配套工具(STARS)：康复信息收集模板(TRIC)》，形成了国际康复政策的架构体系。WHO 的国际康复政策从构建健康体系的六大构成要素入手，提出发展康复的政策与行动指导。本研究从康复服务的六大构成要素，对 WHO 康复政策涉及的康复领导力和治理、康复筹资、康复人力资源、康复服务提供、康复医药技术及康复信息系统六大领域内容，从宏观的理论与政策、中观的服务体系以及微观的服务提供三个层次，系统研究 WHO 国际康复政策架构与体系。

1.2 健康服务体系视域下康复发展的原则与目标

1.2.1 建立以人为本的康复服务体系

WHO 发布《健康服务体系中的康复》明确指出，康复有助于提供全面的以人为本的保健[4]，保证人们在不同环境中都能实现其功能潜力[5]。以人为本的重点是满足人的需求或偏好[6]。构建以人为本的康复服务，要求以人为中心，而不是仅仅关注疾病本身；要针对人的个性化需求，提供符合其期待与偏好的康复和医疗服务，并帮助个人、家庭和社区进行医疗决策。

康复服务是健康服务的重要组成部分。根据 ICF，健康是身体功能与结构、活动和参与以及环境因素共同作用的结果，现代康复服务从传统意义上的“残损-残疾-残障”医学治疗模式，转变为当代“生物-心理-社会”健康模式[7]，综合考虑个人的健康状况、功能状态和自然环境、社会环境之间的交互作用，借助多种干预手段，改善健康环境，提高个体身体功能与活动参与水平，保障生活质量与福祉[8]。

1.2.2 关注康复发展的社会决定因素

健康的社会决定因素是影响健康结果的非医疗因素，包括人们出生、成长、工作、生活时的条件和年龄的限制，是塑造日常生活条件更为广泛的力量和系统[9]。健康公平在社会决定因素中起着核心作用[10]，联合国2030年可持续发展议程和WHO都倡导，要求减少卫生不公平[11]，缩小贫富群体间的健康差距，建立可持续发展卫生框架[12]，促进实现全民健康覆盖，提高健康服务的可及性和有效性。康复服务关注功能状态等社会决定因素，通过提供高质量的康复服务，提升全民健康覆盖的水平，提高人口整体健康和福祉。

1.2.3 发展康复是实现联合国可持续发展目标的重要路径

联合国提出2030年可持续发展目标三："确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉"，即"全民健康覆盖"。全民健康覆盖是指所有有需要的个体和社区都能获得所需的卫生服务，而不会陷入经济困境，它涵盖全方位、高质量的基本卫生服务。发展康复是实现联合国可持续发展目标全民健康覆盖的关键环节。WHO在"康复2030：行动呼吁"主题会议上强调，发展康复服务对实现联合国可持续发展目标具有重大意义[13]，提倡强化康复在健康服务体系中的重要地位[14]，将康复服务融入健康服务体系中；要求大力发展和扩展康复服务，在各级健康服务体系中提供康复服务并保障康复服务质量[15]，最终实现全民康复服务覆盖，提升康复服务的有效性、可及性和可负担性。

2 国际康复政策架构分析

2.1 国际康复政策架构和行动战略结构层次与内容分析

康复属于健康相关服务，发展康复是实现联合国2030年可持续发展目标的重要环节。2006年，联合国通过《残疾人权利公约》[16]，旨在促进、保护和确保实现残疾人能够全面和平等地享有所有人权，并促进对残疾人固有尊严的尊重。2014年，WHO颁布《全球残疾行动计划2014-2022》[17]，倡导发挥所有残疾人的潜能，生活在平等、有尊严的环境中，实现最佳健康、功能、福祉和人权。2015年，联合国发布《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》，提出2030年可持续发展目标，其中目标三为"确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉"。2017年，WHO在日内瓦召开了主题为"康复2030：行动呼吁"的国际会议，提倡关注日益增长的康复需求，强调康复服务的重要性。

WHO先后发布《健康服务体系中的康复》《健康服务体系中的康复：行动指南》《康复指标清单：康复监测和评估架构配套的工具》[18]《康复现状系统评估配套工具(STARS)：康复信息收集模板(TRIC)》[19]，在循证和专家知情建议的基础上，提出基于WHO健康服务六大构成要素的康复政策架构，这六大构成要素包括：领导力和治理能力、筹资、健康人力资源、服务提供、医药技术、健康信息系统。基于六大要素，国际康复政策架构与行动战略的架构和内容可以从康复理论与政策、行动战略和实施方法与工具三个层面进行分析。见图2。

2.2 国际康复政策、行动战略和实施方法的内容分析

2.2.1 康复领导力和治理

在理论与政策层面，发展领导力与提升治理能力关系到卫生健康战略和康复政策的实现。要根据康复发展的需要，优先完善法律政策和治理体系，提升领导力和治理能力。

在行动层面，要求加强康复立法，建立适应康复发展的治理体系，提升治理能力和规划执行水平，明确康复工作的负责部门和人员，在健康服务体系中建立治理和问责制，并明确辅助技术相关规定。

康复领导力和治理评价指标体系中，涉及领导力和治理行为的指标包括是否将康复纳入国家健康战略或相关卫生规划，国家康复状态及监测的常规康复报告是否能反映康复服务领导力、治理能力和问责制度的程度，治理措施在管理和监督方面的作用，患者是否是康复服务治理的一部分，是否对优先辅助产品提供领导与支持，以及儿童发展政策；在评估康复领导力和治理效果方面，可以分析工作部门和负责人员、健康战略和康复政策及其协调与监测、患者需求信息。

2.2.2 康复筹资

明确康复筹资是一种长期投资，良好的资金分配体制能对服务提供和健康公平产生显著影响。要建立多种康复筹资的渠道，如将康复服务纳入健康保险、改善再分配制度、提高康复服务的平等性，加大康复投资，扩大康复规模，提升康复服务的覆盖率、可及性和有效性；同时制定收费和支付的标准，降低在康复领域的个人支出额度。

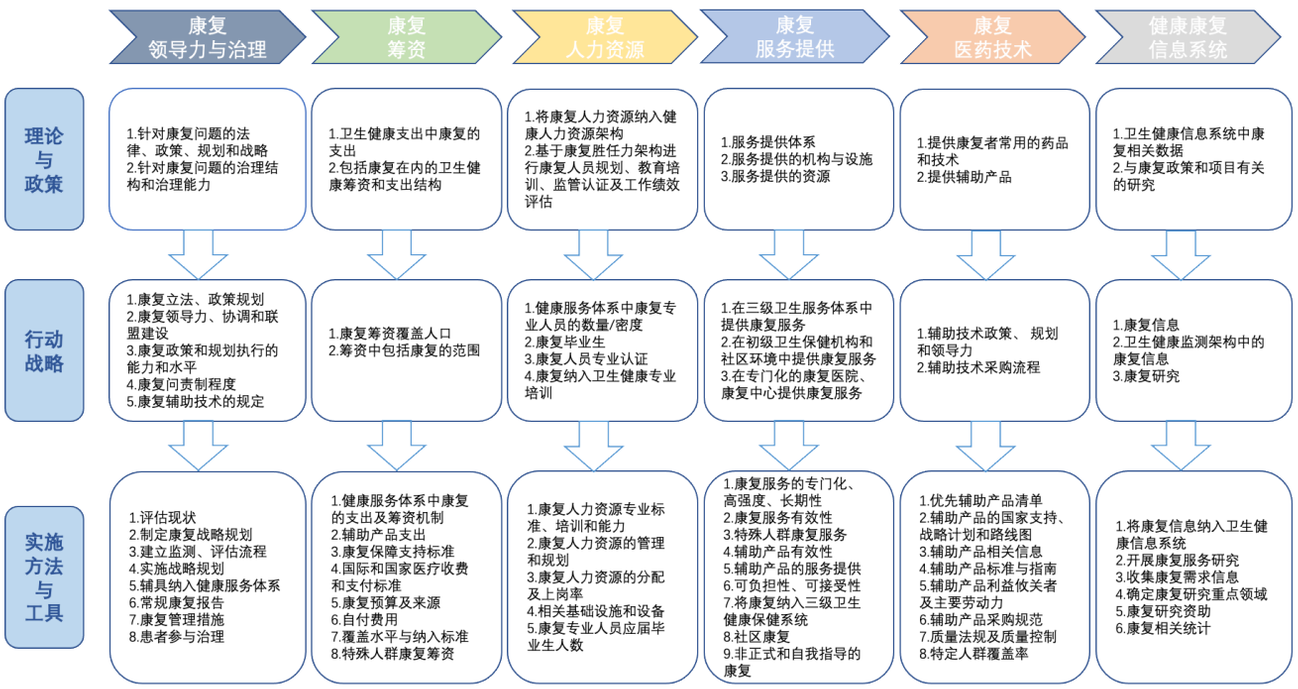


图2　国际康复政策、行动战略与实施方法系统内容结构图

在行动规划方面，需建立符合国情的筹资机制与规划，确保康复筹资覆盖人口及范围。

在指标体系方面，需考察康复服务支出在国家卫生服务总支出的占比、国家为辅助产品承诺的支出[20]、康复保障的相关标准以及医疗收费和支付标准。在筹资绩效评估方面，需分析康复预算及来源、医疗总支出、辅助产品年度支出和占比、主要卫生筹资机制和人口覆盖水平与纳入标准、国家自付费用的医疗费用占比、筹资康复服务类型、特殊人群康复筹资。

2.2.3 康复人力资源

将康复人力资源的发展纳入健康人力资源体系，根据健康人力资源的要求，建立康复胜任力理论架构，并且运用该理论架构分析与发展适用于康复领域不同专业的胜任力方案。

康复人力资源的配置要根据康复服务的规模，保障配备康复专业人员的康复设施总数，满足康复发展的需要。

评价康复人力资源的相关指标包括：康复服务提供人员是否有向需求者提供专业服务的胜任力以及面对复杂的需求是否可以提供多学科康复服务，是否解决人力资源的分配问题，应届康复专业毕业生人数，卫生健康人员的专业认证是否有专业标准，卫生健康专业人员的康复相关培训等。康复人力资源效果评价指标包括：健康人力资源涉及物理治疗师、作业治疗师、言语和语言治疗师、听力学家、假肢师和矫形师、物理康复医生、心理学家及其他康复专业人员，康复专业人员在各级医院的上岗率、配备康复专业人员设施总数等。

2.2.4 康复服务提供

在服务体系建设上，要将康复服务纳入健康服务体系之中，针对个体的健康状况或功能障碍提供相关服务。在服务体系建设与服务提供方面，应该在规划上将康复服务纳入各级健康服务体系之中、之间，应在社区和专门化的康复医院、康复中心提供康复服务，保障服务的可及性、可负担性、有效性及服务质量，并且建立服务评价机制。

在康复服务评价的指标体系方面，康复服务提供评价指标包括人均康复床位总数、含有三个或以上康复人员的三级医院的比例、康复服务应包括三种及以上学科、康复病床和日间活动场所、拥有两个或多个康复专业的二级医院的比例、提供康复服务的初级保健设施比例、社区提供康复服务的可及性、卫生健康机构提供辅助产品的能力、康复临床指南适合国情的情况、康复标准是否支持高质量的康复指南、康复服务的及时性、康复服务的平均等待时间、康复服务的

疗程、康复疗程的强度、康复服务前的康复评估、个性化康复服务的制定、康复转介的顺利进行、康复患者的教育、康复患者在康复服务期间的自我报告、医疗机构或服务提供者为特定问题提供的保健服务、辅助产品发放总数、康复过程中患者身体功能的变化[21]、特定人群的康复服务覆盖率、特定人群的辅助产品覆盖率、通过WHO示范残疾调查的措施进行人口调查。在康复服务效果评价方面，相关的指标包括是否有专门化、高强度、长期的康复服务，是否将康复纳入初级、二级、三级卫生健康保健，是否提供社区康复，是否提供非正式和自我指导的康复，是否提供整个康复保健期间的服务，包括急性期、亚急性期和长期保健期，是否提供儿童康复，是否提供特定目标人群的康复并分析康复数量和质量。

2.2.5 康复医药及技术(特别是辅助技术)

在康复发展中，将辅助技术产品与服务纳入康复技术领域。康复相关医药及技术有利于改善身体功能、提高个体独立性和社会参与度，辅助产品对公平、高质量的服务提供具有重要意义。

在行动层面，要求针对个别化需求，提供医药及技术，特别是辅助产品，明确辅助产品采购流程，提高辅助产品的可及性、可负担性和特殊人群覆盖率，并适时对康复服务提供者和辅助产品使用者提供培训。

服务规划与服务提供评价指标包括：是否对优先辅助产品提供领导与支持、国家为辅助产品承诺的支出、卫生健康机构提供的辅助产品的有效程度、辅助产品发放总数、特定人群的辅助产品覆盖率。在服务效果评估方面，主要指标涉及辅助产品的战略、计划和路线图，基本辅助产品清单，财务及补贴机制、监管机制，书面指南和服务标准，提供辅助技术的主要利益攸关方，辅助产品采购技术规范，主要劳动力，辅助产品类别，质量法规和服务标准。

2.2.6 健康康复信息系统

现代康复服务需要获得康复需求与发展的相关信息，并且基于信息和研究证据建立国家的康复战略和规划。为实施WHO《健康服务体系中的康复》相关政策，需要采取行动，构建功能、残疾和康复服务的数据架构与标准，搭建现代大数据平台，建立相关数据信息库，根据数据分析结果进行与康复政策与项目有关的研究。。

在国家康复规划中，涉及康复信息的相关核心指标包括：是否将康复信息纳入卫生健康信息系统、是否将康复服务指标纳入国家卫生健康监测架构及康复相关研究。在康复服务效果评估方面，需要定期收集人口功能信息、康复质量和康复结局可用性数据、政府与非政府组织的数据、ICF数据、政府报告相关顶层指标、康复研究重点领域、康复研究主要资助机构和康复统计方法，并在决策过程中使用康复信息。

3 国际康复战略行动主要领域及其核心内容分析

根据WHO健康服务构成要素的理论，本研究系统分析了在康复服务构成的六个领域，国际康复政策与康复行动战略的主要内容。六大领域涉及领导力和治理能力、筹资、服务提供、健康人力资源、医药技术、健康信息系统。在健康服务体系视域下发展健康和健康相关服务，要求特别关注康复领导力和治理、康复筹资、康复服务提供、康复人力资源、康复医药与技术、康复信息系统六大领域，构建康复服务治理体系并提高治理能力，为康复服务筹措必要资金，培养多学科康复专业人员队伍，提高康复服务质量，发展新型康复医药及技术，构建涵盖功能数据的信息系统。

3.1 加强康复服务领导力、治理、规划和协调能力

在领导力和治理能力领域，WHO的健康服务体系及其行动指南倡导各国为发展康复，制定国家康复战略，强化国家内部康复服务的领导力以及治理。①评估现状，系统评估国家康复状况，了解国家康复需求；②制定康复战略规划，依据现状评估的标准化报告，指导康复服务的规划和发展；③建立监测、评估和复审流程，构建康复监测和评估架构，及时跟踪康复服务进度；④实施战略规划，付诸行动，加强国家内部康复工作。

要求制定国家康复计划，将康复的发展规划纳入国家卫生健康发展战略，并出台相关康复法律与政策，制定针对康复服务的评价指标，确保康复服务的可及性、可负担性、有效性和服务质量，并制定专门的康复政策与机制，为特殊人群康复提供支持。

3.2 构建合理的康复筹资机制,为康复筹措必要资金

为了实现康复全覆盖，应根据《健康服务体系中的康复》的政策要求，将国家财政资源分配给康复服务，以促进公平地提供康复服务。筹措充足的财政资金，建立强有力的康复筹资机制，是实现全民健康覆盖的重要举措。为构建强有力的康复融资机制，加强康复相关部门与财政相关部门的协调，扩大补贴[22]，

合理进行资源规划，加大康复服务机构财政投入，创新筹资方式，鼓励康复领域投资，提高重点人群财政保障[23]，将健康保险覆盖康复服务，以提高康复服务的公平性、可及性和可负担性。

3.3 健全康复人力资源培养与保障机制，提升康复人员专业能力

要将康复人力资源纳入健康人力资源范畴，WHO 为此颁布了《康复胜任力理论架构》以及配套的两项应用指南技术文件。为发展康复服务，提升康复服务质量，在康复人力资源领域，要求建立多学科康复人员队伍，保障人力资源的胜任力，加强教育和专业培训，形成多学科、跨行业、多部门协作的人力资源体系。WHO 康复胜任力相关文件指导各国建立基于胜任力的康复专业人员的培养与保障机制，包括康复工作人员提供和支持康复服务所需的核心价值观和信念、能力、活动与其包含内容以及基本知识和技能。健全康复人力资源的培养与保障机制，要求按照康复胜任力规划，构建康复相关学科体系、教育培训体系和人才认证体系，建立人才使用及激励机制[24]，保障高质量康复人力资源输送渠道，保证康复服务行业工作人员的继续教育[25]，加大康复服务资金投入力度，并合理配置康复人力资源，以提高康复专业人员能力。

3.4 提升康复服务提供能力并改善服务质量

基于 WHO 健康服务体系的理论，康复服务应有效整合到健康服务体系中，改善服务质量，提高康复服务的可持续性。①将康复服务融入健康服务连续体中，在预防、干预、康复和健康促进四个环节发展康复服务，构建完善的康复服务体系。②将康复服务纳入三级健康服务体系，在初级、二级和三级健康服务体系之中和之间建立协调机制，培训具有胜任力的专业人员，加大康复投资，制定专门的卫生健康保健机制和服务包，以提供所需的康复服务和干预措施。③将康复服务融入社区和公共卫生领域，将康复服务扩大到社区，明确社区服务提供机构和社区服务提供范围，营造良好康复氛围，建设支持长期康复的健康环境。④在特殊康复领域，针对重大疫情造成的伤害提供康复服务，为特殊人群制定专门化康复计划，提供个别化康复装置，满足人群特殊要求[26]。⑤基于有效循证康复服务的国家临床实践指南，整合康复服务和健康服务体系，采用目标设定、多学科团队合作和功能结果测量的方法，建立以人为本的康复保健服务，在连续保健过程中及时提供康复服务。

3.5 提高辅助产品和辅助技术服务的质量与可及性

WHO 对辅助技术的定义是“包含提供辅助器具和服务相关的组织以及知识和技能的运用”，人人有权享有辅助技术[27]。《健康服务体系中的康复》首次在政策上将辅具纳入康复服务体系的构成要素，并针对辅具服务提出了相关技术规范。《政策简报：获取辅助技术》提出，辅助技术的提供需要建立以人为本的技术生态系统，明确服务标准，构建服务网络和政策体系，以提供高质量和高效的辅具产品和康复服务。WHO 全球辅助技术合作提出 5P 模式[28]，包括个人(people)、政策(policy)、产品(products)、供应(provision)和人员(personnel)，5P 模式有助于推动获得优质辅助技术和服务，提高康复服务的可及性、可负担性、有效性和服务质量，实现联合国可持续发展目标。

3.6 建立涵盖功能、残疾和康复的健康信息系统并开展康复科学研究

为了发展康复，促进康复服务融入健康服务体系，根据 WHO 健康服务体系的相关理论，需建立数据驱动的康复服务信息系统和数据库，对康复行业的发展提供数据支持[22]。建设综合性康复服务大数据平台和数据库，要求基于 ICF 分类体系，依据统一的术语与方法，建立统一的分类标准，将功能信息纳入康复信息系统，构建高水平的康复服务大数据平台，建立康复相关数据及信息收集和分析系统[29]，开展数据驱动的康复研究，与健康服务和其他健康相关服务进行信息资源共享与交换，以为制定康复规划提供支撑。

开展基于循证和数据支撑的康复科学研究。康复科学作为交叉学科，需要采用多学科的研究方法，从不同学科角度，建立基于 ICF 有关功能、残疾和健康分类理念的现代康复科学体系，并将康复科学研究成果转化到康复服务领域，从而进一步提升康复服务的质量和安全性，提升康复服务对象的生活质量和福祉[30]。

4 结论

本研究基于健康服务体系六大构成要素，从宏观、中观和微观三个层面，系统研究国际康复政策架构。现代康复发展的理念是要实现全民健康覆盖，发展康复必须建立以人为中心的现代健康服务体系，并且关注社会决定因素，康复是实现联合国 2030 年可持

续发展目标的重要举措。

围绕康复领导力和治理、康复筹资、康复人力资源、康复服务提供、康复相关医药技术以及康复与健康信息六大领域，从理论与政策、政策行动、实施工具和路径(评价指标体系和实施效果评估)三个层级，构建了康复发展的政策和行动战略以及具体的实施路径与方法体系。

学习应用WHO康复政策相关文件及其工具，需要采取如下行动：①加强康复服务领导力、治理、规划和协调能力；②构建合理的康复筹资机制，为康复筹措必要资金；③健全康复人力资源培养与保障机制；④提升康复人员专业能力，提升康复服务提供能力并改善服务质量；⑤提高辅助产品和辅助技术服务的质量和可及性；⑥建立涵盖功能、残疾和康复的健康信息系统并开展康复科学研究。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] 世界卫生组织,世界银行. 世界残疾报告(国际中文版)[R]. 邱卓英,译. 日内瓦:世界卫生组织, 2013.

World Health Organization, The World Bank. World Disability Report (International Chinese Version) [M]. QIU Z Y, trans. Geneva: World Health Organization, 2013.

[2] 邱卓英,郭键勋,李伦,等. 世界卫生组织康复指南«健康服务体系中的康复»:背景、理论架构与方法、主要内容和实施[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(1): 16-20.

QIU Z Y, KWOK J K F, LI L, et al. World Health Organization Rehabilitation Guide Rehabilitation in Health Service System: background, theoretical framework and methods, main contentsand implementation [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2020, 26(1): 16-20.

[3] World Health Organization. Universal Health Coverage (UHC) 2019 [EB/OL]. [2019-07-18]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ universal-health-coverage-(uhc).

[4] 世界卫生组织. 健康服务体系中的康复[M]. 邱卓英,郭键勋,李伦,译. 香港:香港复康会, 2019.

World Health Organization. Rehabilitation in Health Systems [M]. QIU Z Y, KWOK J K F, LI L, trans. Hong Kong: the Hong Kong Society for Rehabilitation, 2019.

[5] FRANK A O, CHAMBERLAIN M A. Rehabilitation: an integral part of clinical practice [J]. Occup Med, 2006, 56: 289-293.

[6] JESUS T S, BRIGHT F, KAYES N, et al. Person-centred rehabilitation: what exactly does it mean? Protocol for a scoping review with thematic analysis towards framing the concept and practice of person-centred rehabilitation [J]. BMJ Open, 2016, 6: e011959.

[7] 世界卫生组织. 国际功能、残疾与健康分类(国际中文增补版)[M]. 邱卓英,译. 日内瓦:世界卫生组织, 2015.

World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health (International Chinese Supplement) [M]. QIU Z Y, trans. Geneva: World Health Organization, 2015.

[8] 邱卓英,李伦,陈迪,等. 基于世界卫生组织国际健康分类家族康复指南研究:理论架构和方法体系[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(2): 125-135.

QIU Z Y, LI L, CHEN D, et al. Research on rehabilitation guidelines using World Health Organization Family International Classifications: framework and approaches [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2020, 26(2): 125-135.

[9] World Health Organization. Social determinants of health [EB/OL]. [2019-07-18]. https://www. who. int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab1.

[10] SOLAR O, IRWIN A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social Determinants of Health Discussion [R]. Geneva: World Health Organization, 2010.

[11] 世界卫生组织. 针对健康问题社会决定因素采取行动以减少卫生不公平[EB/OL]. (2009-05-22). http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-ch.pdf?ua=1.

[12] The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, WHO, World Bank, et al. Success Factors for Women's and Children's Health study series: journal articles and reports [R]. Geneva: WHO, 2015.

[13] 世界卫生组织. 康复2030:行动呼吁. 背景文件:康复:21世纪卫生健康的关键[R]. 日内瓦: 世界卫生组织, 2017.

World Health Organization. Rehabilitation 2030: a call for action. Background paper: Rehabilitation: Key for health in the 21st century [R]. Geneva: World Health Organization, 2017.

[14] 世界卫生组织. 健康服务体系中的康复:行动指南[M]. 李伦,陈迪,李安巧,等,译. 香港:香港复康会, 2020.

World Health Organization. Rehabilitation in Health Systems: Guide for Action [M]. LI L, CHEN D, LI A Q, et al., trans. Hong Kong: the Hong Kong Society for Rehabilitation, 2020.

[15] World Health Organization. Rehabilitation 2030: a call for action [EB/OL]. (2017-04-16). http://www. who. int/disabilities/care/rehab-2030/en/.

[16] 联合国. 残疾人权力国际公约[A]. A/61/611. 纽约: 2006.

United Nations. Convention of the Rights of Persons with Disabilities [A]. A/61/611. New York: 2006.

[17] 世界卫生组织. 世卫组织2014~2021年全球残疾问题行动计划:增进所有残疾人的健康[J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20(7): 601-610.

World Health Organization. WHO Global Action Plan on Disability from 2014 to 2021: Improving the Health of All Persons with Disabilities [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2014, 20(7): 601-610.

[18] 世界卫生组织. 康复指标清单:康复监测和评估架构配套的工具[M]. 邱卓英,译. 日内瓦:世界卫生组织, 2020

World Health Organization. Rehabilitation indicator menu: a tool accompanying the Framework for Rehabilitation Monitoring and Evaluation (FRAME) [M]. QIU Z Y, trans. Geneva: World Health Organization, 2020.

[19] 世界卫生组织. 康复现状系统评估配套工具(STARS):康复信息收集模板(TRIC) [M].邱卓英,译. 日内瓦:世界卫生组织, 2020.

World Health Organization. Template for Rehabilitation Information Collection (TRIC): a tool accompanying the Systematic Assessment of Rehabilitation Situation (STARS) [M]. QIU Z Y, trans. Geneva: World Health Organization, 2020.

[20] World Health Organization. A system of health accounts. Geneva: World Health Organization [EB/OL]. [2019-06-16]. http://www. who. int/healthaccounts/documentation/system_of_health_accounts_2011/en/.

[21] World Health Organization. WHO Health Systems Strengthening Glossary [EB/OL]. [2019-06-16]. https://www. who. int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html.

[22] 世界卫生组织. 健康服务体系中的康复[J]. 邱卓英,郭键勋,李伦,译. 中国康复理论与实践, 2020, 26(1): 1-14.

World Health Organization. Rehabilitation in health systems [J]. QIU Z Y, KWOK J K F, LI L, trans. Chin J Rehabil Theory Pract, 2020, 26(1): 1-14.

[23] 李欣,陈迪,邱卓英,等. 康复2030:扩大康复规模以满足日益增长的康复需求[J]. 中国康复理论与实践, 2017, 23(4): 380-384.

LI X, CHEN D, QIU Z Y, et al. Rehabilitation 2030: meet ever-increasing rehabilitation needs [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2017, 23(4): 380-384.

[24] 井淇,孙宏伟,邱卓英. 国际康复人力资源构成和配置及其对发展现代康复高等教育的启示[J]. 中国康复理论与实践, 2018, 24(9): 1011-1017.

JING Q, SUN H W, QIU Z Y. Composition and allocation of rehabilitation workforces: implications to development of higher education of modern rehabilitation [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2018, 24(9): 1011-1017.

[25] World Health Organization. Increasing Access to Health Workers in Remote and Rural Areas Through Improved Retention: Global Policy Recommendations [R]. Geneva: World Health Organization, 2010.

[26] 世界卫生组织. 妇女、儿童和青少年健康全球战略(2016-2030) [R]. 日内瓦:世界卫生组织, 2016.

World Health Organization. Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016-2030) [R]. Geneva: World Health Organization, 2016.

[27] World Health Organization. Policy Brief: Access to Assistive Technology [R]. World Health Organization, 2020.

[28] World Health Organization. Framework and Standards for Country Health Information Systems [M]. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2012.

[29] 世界卫生组织. 世卫组织21世纪强化国家卫生健康战略手册[R]. 日内瓦:世界卫生组织, 2016.

World Health Organization. WHO Strategizing National Health in The 21st Century: A Handbook [R]. Geneva: World Health Organization, 2016.

[30] 李沁燚,邱卓英,陈迪,等. 基于ICF构建国家功能、残疾和健康的信息架构和数据体系[J]. 中国康复理论与实践, 2017, 23(4): 385-389.

LI Q Y, QIU Z Y, CHEN D, et al. Construction of national framework and data systems of functioning, disability, and health of information using ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2017, 23(4): 385-389.

(收稿日期:2021-08-31 修回日期:2021-09-13)

View publication stats